

19 - 07- Les cancers cutanés épithéliaux - Pr. Amal

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé les cancers cutanés épithéliaux. Les cancers cutanés épithéliaux, ce sont des cancers qui touchent l'épiderme. L'épiderme est constitué de plusieurs couches, la couche cornée, la couche granuleuse, la couche épineuse et la couche basale.

Les objectifs de ce cours, donc après ce cours, l'étudiant doit être capable d'identifier le facteur prédisposant au cancer cutané, c'est très important, c'est pour améliorer une stratégie préventive. La même chose, il faut identifier les principales dermatoses précancéreuses et les traiter avant leur transformation au cancer cutané. Diagnostiquer un carcinome vasocellulaire, surtout au stade de début, lorsqu'on est devant des petites lésions, pour améliorer le pronostic et la prise en charge thérapeutique du patient.

Distinguer les différentes formes cliniques d'un carcinome vasocellulaire, diagnostiquer un carcinome épidermoïde, connaître les principes thérapeutiques des cancers épithéliaux. Les cancers cutanés épithéliaux sont des tumeurs malignes développées au dépens des cellules épidermiques. Les carcinomes cutanés sont les plus fréquents des cancers humains de l'adulte.

Les carcinomes cutanés sont les plus fréquents des cancers cutanés. Ça représente 90% des cancers cutanés. Leur incidence augmente régulièrement du fait de l'allongement de la durée de vie et des habitudes comportementales, en particulier l'exposition solaire répétée.

Ça touche l'adulte de plus de 40 ans. Le sexe masculin est plus atteint que le sexe féminin. Les sujets de phototype clair vivant dans une région ensoleillée sont plus exposés à développer ces cancers.

Voici le phototype 1 et le phototype 2. Ce sont les personnes vulnérables à développer ces cancers cutanés. Pour les facteurs étiologiques, il y a des facteurs carcinogènes prédisposants et le facteur essentiel, c'est les ultraviolets, les radiations ultraviolettes. C'est l'exposition solaire chronique, surtout depuis l'enfance, ou bien parfois les coups de soleil répétés pendant l'enfance.

Ce sont des facteurs prédisposants pour développer des cancers cutanés. Il y a les radiations ionisantes provoquant des radiodermites chroniques, et ces radiodermites chroniques peuvent se transformer en carcinomes épidermoïdes. Il y a les traumatismes mécaniques et thermiques, donc les brûlures, par exemple, les cicatrices de brûlure, surtout s'ils siègent au niveau des régions photoexposées, peuvent donc évoluer vers des cancers cutanés, essentiellement les carcinomes épidermoïdes.

Lorsqu'on parle des cancers cutanés, il y a deux types de cancers, les carcinomes vasocellulaires et les carcinomes épidermoïdes. Il y a des facteurs chimiques, l'arsénique, le goudron, les hydrocarbures polycycliques, qu'on trouve dans l'industrie du verre, par exemple, l'industrie des huiles artificielles. Il faut penser à ces facteurs lorsque vous avez des cancers, par exemple, localisés au niveau des mains.

L'immunodépression, donc les patients qui sont, par exemple, les patients HIV, ils risquent de développer des cancers cutanés, des carcinomes épidermoïdes. On a vu ça dans le cours sur les manifestations cutanées du VIH. Les malades, par exemple, sous traitement immunosuppresseur, les greffées, par exemple, les greffées rénales, qui sont des malades qui sont sous traitement immunosuppresseur pour éviter le rejet de la greffe, ils développent des cancers cutanés.

Parmi les conseils qu'il faut donner aux greffées, c'est d'éviter l'exposition solaire et également il faut faire des examens tous les six mois à la recherche des lésions précancéreuses ou des lésions cancéreuses au stade de début. Les infections à papillomavirus également, c'est un facteur favorisant des cancers cutanés au niveau de la muqueuse génitale, surtout des carcinomes épidermoïdes. Les UV, c'est surtout les UVA et les UVB qui sont responsables de l'apparition des cancers cutanés.

Les UVB pénètrent au niveau de l'épiderme, ils donnent des altérations génétiques au niveau du keratinocyte. Il agit également sur les mélanocytes, donc il peut y avoir des pigmentations, et sur les cellules de longueur. Ces cellules de longueur interviennent dans l'immunité, donc les UVB provoquent une photo-immunosuppression.

Cette photo-immunosuppression, il favorise également l'apparition des cancers cutanés. Les UVA, ils pénètrent jusqu'au niveau du derme, donc ils donnent des altérations du fibromaste responsables de l'héliodermie, c'est-à-dire c'est le vieillissement, mais également ils favorisent l'apparition des cancers cutanés de façon indirecte par la libération des radicaux. Les UVB agissent par action directe sur l'ADN des keratinocytes, donc en créant une photocarcinogénèse, favorisant des mutations du gène suppresseur qu'on congèle.

Il agit également de façon directe en créant une photo-immunosuppression par l'altération des cellules de longueur. Il agit également de façon indirecte par la libération des radicaux libres, suite à un stress oxydatif. Les UVA agissent essentiellement de façon indirecte par le stress oxydatif également et la libération des espèces réactives de l'oxygène ou des radicaux libres oxygénés.

Toujours dans le cadre des étiologies, là on a des facteurs endogènes. Ce sont des facteurs liés aux patients. Il y a surtout les pathologies génétiques, les dermatoses génétiques, congénitales ou héréditaires.

Vous avez surtout le xérodermatopigmentosisme et l'albinisme. Il y a d'autres maladies. La neuromatose vasocellulaire, là on verra ce qu'il s'est passé.

Mais surtout il faut connaître ces deux maladies qui sont fréquentes dans notre contexte à cause de la consanguinité. Nous avons beaucoup de patients qui ont le xérodermatopigmentosisme. On va voir les photos des malades par la suite.

Il y a aussi les déficits immunitaires. C'est primitif. Il y a les dermatoses inflammatoires chroniques.

Par exemple, un lupus tuberculeux peut se transformer en carcinome épidermoïde. Toutes les dermatoses inflammatoires chroniques peuvent se transformer en carcinome épidermoïde. Voici des enfants qui ont des lésions du xérodermatopigmentosisme.

Ce qu'on appelle les enfants de la lune. Voici ici une jeune fille qui a ce carcinome épidermoïde très étendu. Vous voyez là c'est un carcinome vasocellulaire pigmenté.

Là la même chose, un carcinome vasocellulaire. Là vous voyez des carcinomes vasocellulaires. Même une atteinte au niveau de la muqueuse.

Donc toutes ces ulcérations là ce sont des cancers cutanés. Donc ce sont des enfants qui ont une altération d'une enzyme qui s'appelle l'enzyme. Donc un déficit de l'enzyme de l'endonucléase.

C'est une enzyme réparatrice de l'ADN. Chaque fois qu'on s'expose au soleil, un sujet normal lorsqu'il s'expose au soleil, il y a donc une altération de l'ADN. Mais cette altération elle est corrigée par un système enzymatique.

Il répare ces altérations. Chez ces enfants là, il n'y a pas ce système. Donc ces enfants, lorsqu'ils s'exposent au soleil, ils ont des altérations génétiques et ils développent des cancers cutanés à un âge précoce.

Vous avez l'albinisme, l'albinisme, donc trouble de la pigmentation, non pas de la mélanine. La mélanine permet également, c'est un moyen de photoprotection. Et là, ce sont des sujets qui développent, vous voyez tout ce qui est là, ces lésions un petit peu pigmentées.

Ce sont des keratocytes actiniques qu'on va voir par la suite. Et là, c'est un carcinome épidermoïde. Donc ce sont des maladies qui favorisent l'apparition des cancers cutanés.

Donc on arrive aux lésions précancéreuses. Donc les lésions précancéreuses, ce sont des lésions cutanées qui ont voulu assez fréquemment vers la malignité. Et dont le substrat histologique comporte des atypies nucléaires.

Ils se transforment le plus souvent en carcinome épidermoïde, qu'en carcinome vasocellulaire. Donc il faut craindre le... On va voir ces différentes lésions précancéreuses. Vous avez les keratocytes actiniques au sénile.

Ils présentent cette forme de tache brune ou jaunâtre de surface rugueuse sur les parties découvertes, sur le visage, sur la face dorsale des mains, le cou chevelu, pour les sujets qui n'ont pas de cheveux, les sujets chauves, se voient surtout chez les sujets âgés. Ils se transforment en carcinome épidermoïde, en 5 à 20 % des cas. Il faut craindre la transformation de ces

keratocytes actiniques lorsque vous avez une infiltration des lésions, lorsqu'il y a une apparition d'une ulcération, ou un bourgeonnement.

Donc il faut identifier ces lésions avant leur transformation, et il faut les traiter. Donc on peut traiter ces lésions par cryothérapie. Donc cryothérapie, c'est-à-dire c'est l'application de l'azote liquide.

Donc c'est l'application du froid. L'azote liquide, il est à moins 160 degrés. Ça permet donc la destruction de ces keratocytes actiniques.

La photothérapie dynamique consiste à utiliser donc une crème qui rend ces lésions photosensibilisantes. On expose le malade à une source lumineuse. Il y a des lampes ou parfois la lumière du jour.

L'électrocoagulation, c'est-à-dire la destruction de ces lésions par électrocoagulation, donc on les brûle, ou par le laser CO2. Donc à côté de ces moyens physiques, il y a des produits chimiques. Donc il y a le 5-fluoruracil, c'est une crème qui n'est pas commercialisée au Maroc.

Vous avez le diclofenaxo-dicongel également, elle n'est pas commercialisée au Maroc. Vous avez l'imiquimote, c'est un immunomodulateur, c'est une crème, également elle n'est pas commercialisée au Maroc. Mybutate d'ingénol également, c'est un produit qui n'est pas commercialisé au Maroc.

Donc c'est des produits qui peuvent traiter ces lésions précancéreuses, notamment ces keratose axonique, avant leur transformation. Voici les lésions de keratose axonique au niveau des lésions photo-exposées. Vous voyez des cellules, donc des lésions squameuses, au niveau des lésions photo-exposées.

Voici des lésions cutanées, donc de keratose axonique chez un sujet albinos. Vous voyez les lésions au niveau du pavillon de l'oreille, ce sont des localisations fréquentes au niveau du front, au niveau du jour. Et on a dit que lorsque la keratose axonique s'ulcère, le cas de chez ce patient, là il faut craindre la transformation maligne vers un carcinome épidermoïde.

Donc ici on peut traiter par l'azote liquide ou par les autres moyens qu'on a cités tout à l'heure, mais ici, là il faut faire une exérèse chirurgicale. Là il faut bien sûr confirmer les diagnostics par une biopsie et faire une exérèse chirurgicale. Toujours dans les lésions précancéreuses, on a une corne cutanée que vous voyez ici.

Donc c'est une forme d'une keratose axonique, mais qui est plus longue que large. C'est une excroissance spontanée en éperon. Voici l'aspect d'une corne cutanée au niveau du pavillon de l'oreille.

La même chose lorsque vous avez une infiltration. On voit ici qu'il y a une infiltration, donc ça démontre qu'il y a une transformation maligne par le carcinome épidermoïde. Et là il faut faire une

exérèse chirurgicale.

Voici donc l'aspect d'une corne cutanée. Vous voyez ici, c'est différent. La base ici, on ne voit pas cette infiltration.

On n'a pas, mais déjà, ici on voit que c'est tuméfié, donc c'est infiltré. Au niveau des muqueuses, on a comme lésion précancéreuse la locoplasie, donc cette hache blanchâtre que vous voyez qui se transforme en carcinome épidermoïde. Donc après les lésions précancéreuses, on va voir les carcinomes in situ, c'est-à-dire les carcinomes qui sont strictement intraépithéliales.

Donc vous avez la maladie de Boyle, cutanio-muqueuse, qui peut toucher la peau et les muqueuses. Donc c'est un carcinome épidermoïde peu différencié, strictement intraépithélial. Si on ne le traite pas à ce stade, il va devenir un carcinome invasif.

Cliniquement, vous avez des lésions discoïdes, c'est-à-dire squameuses, arrondies, bien délimitées, de taille variable, de teint brun cuivré, mais il peut y avoir plusieurs colorations. C'est décrit de lésions pigmentées, de lésions irrédémateuses, recouvertes de squames et de croûtes. Le traitement idéal, c'est l'exercice chirurgical.

On peut utiliser la photothérapie dynamique pour les lésions. Lorsqu'il y a une contre-indication à la chirurgie, lorsque vous avez une patiente qui présente un problème, par exemple quelqu'un avec un sujet âgé, à ce moment-là, on peut utiliser soit la photothérapie dynamique, le laser CO2, ou la cryo-chirurgie. Mais le traitement idéal, c'est l'exercice chirurgical.

Aussi, dans l'aspect des lésions, il peut y avoir plusieurs aspects cliniques. Ici, vous voyez un aspect un petit peu rouge cuivré avec des squames blanchâtres. Ici, déjà, on voit qu'il y a des ulcérations, les squames.

En général, plusieurs diagnostics peuvent être discutés. On peut discuter des lésions d'eczéma chronique, mais lorsqu'il n'y a pas d'amélioration sous traitement local, lorsque vous avez la lésion qui persiste de façon chronique, à ce moment-là, il faut faire une biopsie cutanée, donc un aspect chirurgical cuivré. Il peut y avoir des lésions pigmentées.

Là, toujours dans le cadre du carcinome in situ, vous avez la maladie de pagètes mammaire et extramammaire. Mais ici, ce n'est pas un carcinome, mais c'est un indien au carcinome. C'est très important de connaître cette pathologie, surtout au niveau mammaire, parce que le diagnostic, il reste, c'est un diagnostic clinique qu'il faut confirmer par la biopsie, mais c'est un diagnostic qu'il faut évoquer en se basant sur la clinique.

Donc, c'est des lésions exzématiformes au regard du mamelot. Lorsque vous avez des lésions exzématiformes au regard du mamelot, il faut penser à la maladie de pagètes, faire une biopsie qui va identifier ces cellules de pagètes. Il faut chercher un cancer sous-jacent, donc il faut faire une mammographie.

Donc, le plus souvent, on trouve un indien au carcinome, donc un cancer du sein associé. Donc, il faut évoquer ça, la maladie de pagètes, devant une plaque érythématocrouteuse et érosive. Le traitement, c'est l'exérès chirurgical, et il peut y avoir des localisations en dehors du mamelot, il y a donc des localisations vulvaires, et donc il peut y avoir des localisations extrêmement amères.

Également, ça pose le problème du diagnostic différentiel avec la maladie de Bowen, et là, c'est la biopsie qui permet de faire le diagnostic. Donc, on arrive au carcinome vasocellulaire. Les carcinomes vasocellulaires, ce sont des tumeurs mutanées qui ont une maladie locale.

C'est rarement qu'ils donnent des métastats, c'est possible, mais c'est très rare. Ils ont une évolution très lente. Donc, c'est des lésions qui évoluent sur des années.

Ils siègent au niveau des zones photo-exposées. Il n'y a pas d'atteinte des muqueuses, contrairement au carcinome épidermoïde. Et la lésion alimentaire, c'est une perle épithéliomateuse.

C'est une lésion un petit peu rose, translucide, petite élevation rosée, translucide, unique ou multiple, disposée en périphérique des lésions. Donc, il faut essayer de chercher cette perle épithéliomateuse cliniquement. Ça permet de, donc, d'orienter le diagnostic vers un carcinome vasocellulaire.

Ce caractérise par un polymorphisme clinique important, et on va voir les différentes formes cliniques du carcinome vasocellulaire. La dermoscopie également, donc, elle nous a aidés pour poser ce diagnostic de carcinome vasocellulaire. Mais ça, donc, la dermoscopie, c'est plus du domaine du spécialiste.

Donc, on va voir les différentes formes du carcinome vasocellulaire. Vous avez les formes nodulaires, qui représentent 60 % des cas. Uniquement, vous avez une lésion nodulaire saillante.

Donc, rappelez-vous la définition d'une nodule. Donc, c'est une lésion arrondie hémisphérique plus de 1 cm de diamètre, enchâssée dans la peau, ou sessile. Cette lésion est arrondie ou ovulaire, parfois brosselée.

Elle a un aspect de coloration jaune à peau rosée, parfois translucide, souvent telangiectasique. Donc, on voit des vaisseaux dilatés, avec un aspect parfois pseudo-kystique. Vous voyez ici, donc, cette lésion nodulaire, translucide, telangiectasique.

Le carcinome vasocellulaire. La même chose ici. Donc, une lésion perlée, translucide, telangiectasique.

Là, une lésion de plus grande taille. Modulaire, avec des telangiectasies et des érosions. Là, une lésion modulaire multilobée.

On voit qu'il y a plusieurs lobes, et vous voyez ici les vaisseaux. Donc, un aspect

telangiectasique, pulsée, sur ce côté. Et une lésion translucide, à la périphérie.

Donc, à côté de la forme modulaire, vous avez le carcinome vasocellulaire superficiel, ou pagétoïde. Pagétoïde, c'est-à-dire, il ressemble à la maladie de Paget. Donc, ça représente 10 à 25 % des cas, de forme clinique, se caractérise par une évolution très lente, la bordure, elle est toujours perlée, et se localise électivement au niveau du tronc.

Voici les lésions. Donc, les rétromateuses, rappelez-vous, là, ça ressemble à la maladie de Bowen, la maladie de Paget, donc un aspect rouge cuivré avec des squames ici. La même chose ici, avec des érosions et des croûtes.

Là, la même chose avec une bordure qui est pigmentée ici. Parfois, chez des malades, on peut trouver plusieurs lésions du carcinome vasocellulaire superficielle au Pagétoïde, au niveau du tronc. Donc, on a dit que le carcinome vasocellulaire se caractérise par un polymorphisme clinique.

Vous avez également cette forme sclérodermique, donc représente 5 % des cas, et la lésion se présente sous forme de plaques genâtres endurées, scléreuses. Et vous avez la forme dite plan cicatricien. Donc, c'est une plaque à centre cicatricienne, aborcée, fait de perles juxtaposées, parfois ulcérées, siège, surtout au niveau du visage.

Voici un aspect sclérodermique. Donc, à la palpation, c'est scléreux, c'est enduré. Voici une forme ici, la même chose.

Vous voyez, tout ça, c'est cette plaque un petit peu blanchâtre, et il y a une ulcération. Donc, c'est une forme ulcéreuse et c'est une forme scléreuse. Vous avez ici la même chose.

Donc, ici, c'est un aspect de plan, de carcinome vasocellulaire, plan cicatricien. Abordure perlée, le centre blanchâtre scléreux. Ici, il y a également une ulcération.

Vous avez un carcinome vasocellulaire ulcéreux, avec des bords taillés à piques autour d'une bourrelée perlée. Vous avez cette forme, donc, la forme térébrante. C'est la forme la plus méchante.

Ça donne des ulcérations des parties molles, qui peuvent aller jusqu'à l'os, avec des bords taillés à piques, où on brûlait même le nez. Et vous avez la forme pigmentée, c'est-à-dire un aspect noirâtre de la lésion. Ça peut être toute la lésion noirâtre, ou bien juste l'abordure qui est noirâtre.

Et il peut y avoir l'association des formes cliniques. Par exemple, vous avez un carcinome vasocellulaire ulcéreux et pigmenté. Donc, ici, une forme de carcinome vasocellulaire ulcéreux, avec une atteinte du bord libre de la paupière.

Vous voyez, donc, la bordure surélevée perlée. Une forme ulcéreuse, avec des croûtes, donc, à l'assèchement du sang. Donc, ici, vous avez un aspect de carcinome vasocellulaire térébrant,

avec des restrictions, donc, des parties molles.

Donc, il peut y avoir une destruction de l'os. Il peut y avoir une destruction du globe oculaire. C'est la forme la plus sévère.

Vous avez ici une forme de carcinome vasocellulaire pigmenté. Et vous voyez ici que c'est un plan cicatriciel. Vous voyez l'aspect blanchâtre cicatriciel.

Et vous avez, donc, cette bordure qui est pigmentée. Il peut y avoir l'association des formes cliniques. Et là, c'est un carcinome vasocellulaire modulaire, mais qui est pigmenté.

D'accord? Donc, carcinome vasocellulaire. Ici, vous voyez, donc, une forme ulcéreuse pigmentée. La même chose ici, un plan cicatriciel pigmenté, la bordure est pigmentée.

Ici, un carcinome vasocellulaire modulaire. Là, une forme térébrante, avec une destruction du globe oculaire. Le diagnostic différentiel du carcinome vasocellulaire se pose avec les tumeurs annexiales.

Et là, c'est en général l'histologie qui permet de faire la différence entre ces tumeurs annexiales qui peuvent avoir un aspect clinique semblable au carcinome vasocellulaire, surtout dans la forme nodulaire. Le mélanome, en cas de carcinome vasocellulaire pigmenté, et là, la dermatoscopie permet de faire la part entre ces deux lésions et l'histologie. Le carcinome épidermoïde, surtout dans la forme ulcéreuse.

Le keratocystique, surtout le keratocystique pigmenté. Le métastase cutané d'une tumeur, donc le cancer du sein, d'une tumeur digestive, tumeur gynécologique chez la femme. Donc, ça peut donner des lésions nodulaires et ça peut poser le problème de diagnostic différentiel avec le carcinome vasocellulaire.

Un névus dermique également peut parfois poser le problème de diagnostic différentiel avec le carcinome vasocellulaire nodulaire. Donc là, un mélanome nodulaire. Donc ici, un carcinome spinocellulaire nodulaire également.

Un névus dermique. Donc, le diagnostic de confirmation, c'est un diagnostic histologique. Donc, on fait une biopsie cutanée pour confirmer le diagnostic.

Qu'est-ce qu'on trouve sur le plan histologique ? On trouve que le derme est envahi en partie ou en totalité par une prolifération épithéliale trabiculée ou lobulée de cellules monomorphes de type basale. C'est pour cela qu'on appelle ça carcinome vasocellulaire. La prolifération, elle est au niveau du derme.

Donc, le carcinome vasocellulaire et le carcinome épidermoïde, l'envahissement tumoral, touchent le derme. Les cancers intra-épithéliaux, on a vu tout à l'heure, c'est surtout la maladie de Bowen. Donc, on trouve également une disposition palissadique sans maturation kératinisante

parce que c'est des cellules basales ouïdes.

La maturation kératinisante, c'est dans le cadre du carcinome épidermoïde. Donc, vous avez là la prolifération tumorale. Donc, là, c'est l'épiderme.

La prolifération tumorale, elle est au niveau du derme. Donc, ici, se forment des lobules carcinomateux. Vous voyez ici, qui envahissent le derme.

Donc, l'envahissement. Donc, les lésions lobulaires, prolifération tumorale, moléculaires. Le carcinome vasocellulaire, c'est une tumeur à malignité locale.

Les métastases sont exceptionnelles. C'est une évolution. Ils ont une évolution très lente.

Le traitement, c'est la chirurgie. C'est le gold standard. Donc, c'est le traitement idéal.

C'est la chirurgie, l'exercice chirurgical, le contrôle histologique. Parfois, on est devant des malades inopérables, soit à cause de la tumeur qui est de grande taille, soit à cause d'une contre-indication, sur la patient âgé, en altération de l'état général. À ce moment-là, on peut discuter d'autres méthodes thérapeutiques.

La radiothérapie, la cryosurgery. Actuellement, il y a des traitements développés qu'on appelle les thérapies ciblées. Ce sont des médicaments qui coûtent très cher, en général, pour des malades, des tumeurs de grande taille inopérables.

Le carcinome vasocellulaire risque de récidiver dans 5 % des cas. Ce qui impose une surveillance de tous les patients opérés pour un carcinome vasocellulaire. Bien sûr, le traitement préventif est important.

Et là, le traitement préventif, c'est essentiellement la photo-protection dès l'enfance. Donc, il faut une surveillance régulière de ces patients, au moins une fois par an pendant 5 ans, et idéalement à vie. Donc, il faut des malades, il faut les suivre.

Parce qu'il y a le risque de récurrence, comme on vient de le voir, dans 5 % des cas, ou l'apparition d'un nouveau carcinome cutané, soit vasocellulaire, soit carcinome épidermoïde. Il faut diagnostiquer de façon précoce et les traiter de façon précoce. Pour le carcinome épidermoïde, l'incidence est plus faible que celle du carcinome vasocellulaire.

Toujours le soleil est le facteur carcinogène important. Il survient le plus souvent sur une lésion précancéreuse. On a dit que les lésions précancéreuses qu'on a citées tout à l'heure, donc les keratocytes cyniques, la corne cutanée, la leukoplasie, ce sont des lésions qui évoluent vers le carcinome épidermoïde plus que le carcinome vasocellulaire.

Donc, cliniquement, les lésions, en général, siègent au niveau des régions photo-exposées, au niveau de la face, siègent également au niveau des membres, mais il y a atteinte des organes

génitaux, et là, c'est soit secondaire à des dermatoses inflammatoires chroniques, comme le lichen vulvaire, par exemple, ou le papillomavirus. Une mycose buccale chez les fumeurs, par exemple, qui ont ces lésions de leucoplasie, qui peuvent se transformer en carcinome épidermoïde. Donc, contrairement au carcinome vasocellulaire, le carcinome épidermoïde ne respecte pas les muqueuses.

Il y a l'atteinte de la peau et des muqueuses. Donc, la lésion, ça peut être une lésion routeuse au départ, un aspect vésiculeux, donc une lésion jaunâtre, endurée avec l'ulcération centrale. Et vous avez, donc, le plus souvent un aspect ulcéro-végétant ou ulcéro-bourgeonnant, surtout pour les lésions, donc, qui ont évolué depuis un certain nombre de temps.

Ici, par exemple, c'est ce patient, cette ulcération, cette perte de substance, avec cet aspect végétant, donc une lésion ulcéro-végétante. Et vous voyez que c'est un patient qui a des lésions, donc, de keratose actinique, témoignant d'une exposition solaire, donc très importante. Donc, l'atteinte au niveau du cou chevelu, vous avez une perte de substance, et vous avez un aspect végétant très manifeste, donc une lésion ulcéro-végétante.

Donc là, cette lésion un petit peu vésiculeuse, avec cette lésion modulaire, donc c'est un carcinome épidermoïde, et là, le diagnostic différentiel avec ce qu'on appelle le keratose actinique. Là, cette lésion jaunâtre, sur une ulcération au niveau de la semimucuse, donc c'est un carcinome épidermoïde. Là, le tabac est un facteur, donc, favorisant à côté de l'exposition solaire, facteur favorisant le développement de ce type de cancer.

Là, vous voyez cette ulcération dans la muqueuse génitale, avec un aspect végétant. Le diagnostic différentiel du carcinome épidermoïde se pose avec le keratoacanthoma, le botryomycom, le botryomycom, c'est un bourgeon, ce qu'on appelle également le bourgeon charnu. Après, par exemple, une plaie, il peut y avoir un bourgeonnement avec un saignement de contact.

Le keratose actinique, donc le keratose actinique, c'est une lésion précancéreuse. Il faut craindre la transformation vers un carcinome épidermoïde lorsque ce keratose actinique devient infiltré ou ulcéré ou bourgeonnant. Vous avez le mélanome acromique, un mot le carcinome baso-sébasien.

Donc là, c'est le keratoacanthoma. Le keratoacanthoma, c'est une lésion nodulaire, que vous voyez ici. Au départ, vous avez cet aspect un petit peu keratosique au sommet de cette lésion nodulaire et puis il y a une régression spontanée de la lésion.

Certains auteurs considèrent le keratoacanthoma comme une forme clinique du carcinome épidermoïde. Sur le plan histologique, parfois il est difficile de faire la part entre ces deux lésions. Bas d'un botryomycom, donc secondaire séquence cellulaire, botryomycom, bourgeon charnu.

La même chose pour confirmer le diagnostic, on fait une biopsie cutanée et une étude

histologique. Dans l'étude histologique, on a la prolifération intradermique. Irrégulière et anarchique de cellules malpignantes subissant à des degrés divers une maturation cornée sous la forme d'un mât épithéliomateux lobulé ou trabeculé.

Contrairement au carcinome baso-cellulaire où vous avez des cellules basaloïdes, ici vous avez des cellules malpignantes avec une maturation variable, une maturation cornée variable. Voici une cellule maligne qui est ratisée. En général, vous avez des proliférations au niveau du derme faites par ces cellules ratisées sous forme lobulaire ou trabeculaire.

Le carcinome épidermoïde peut donner, à côté de l'extension locale, des métastases ganglionnaires. Il faut faire un examen des ailes ganglionnaires. Il peut donner également des métastases viscérales, surtout au niveau du poumon, au niveau du foie.

On fait une exploration radiologique, une échographie, TDM, radiotourment, pour détecter ces métastases. Le traitement du carcinome épidermoïde, vous avez la prévention, c'est très important, la photoprotection dès le jeune âge, dépister les lésions précancéreuses et les traiter. La destruction des caractéristiques axoniques, soit par des méthodes physiques ou chimiques, l'exercice chirurgical des leukoplasies muqueuses qui peuvent se transformer en carcinome épidermoïde.

Et vous avez un traitement curatif, c'est comme pour le carcinome baso-cellulaire, c'est la chirurgie qui reste le traitement de référence. Bien sûr, s'il y a une contre-indication de la chirurgie, on utilise actuellement les thérapies ciblées comme pour le carcinome baso-cellulaire, mais ce ne sont pas des médicaments qui ne sont pas encore disponibles au Maroc, tant qu'on utilise parfois la radiothérapie en cas de contre-indication à la chirurgie. Le curage ganglionnaire, c'est la présence d'adénopathie, on ne fait pas de curage ganglionnaire systématique, sauf s'il existe des adénopathies à ce moment-là, on fait un curage ganglionnaire.

La chimiothérapie, c'est la métastase viscérale. Donc il y a ici, là, c'est des patients publiés par l'équipe de CHU de Fès, des malades avec des tumeurs historiques. Vous voyez, donc une ulcération, c'est un carcinome épidermoïde du visage.

Là, la même chose, des lésions étendues au niveau du dos, donc des lésions, un carcinome épidermoïde viriqueux au niveau de la main. Au même schéma du suivi des patients pour les carcinomes vasocellulaires, vous avez, il faut une surveillance régulière, au moins une fois par an pendant cinq ans et idéalement à vie pour dépister une récurrence de la lésion et l'apparition de nouveaux carcinomes cutanés. Donc pour conclure, les cancers cutanés et pitiloïdes sont des cancers fréquents, sont dus essentiellement à l'exposition solaire, surtout chez les sujets de phototypes clairs.

Le carcinome vasocellulaire, c'est une tumeur à malignité locale. Les carcinomes épidermoïdes, ils peuvent donner des métastases ganglionnaires ou viscérales. Les carcinomes épidermoïdes surviennent le plus souvent sur des lésions précancéreuses, d'où l'intérêt d'identifier ces lésions

précancéreuses et d'instaurer un traitement.

La chirurgie est le traitement de référence pour ces tumeurs. Si on opère les malades à un stade précoce, à ce moment-là, on a un taux de guérison de 90 à 95 %. La surveillance s'impose, donc une surveillance régulière, donc idéalement à vie, pour dépister le récidivisme ou l'apparition de nouveaux cancers. Je vous remercie de votre attention.